PROFESIONAL

EJE 4 · INNOVACIÓN, TECNOLOGÍAS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Guía digital y registro QR para prevenir y tratar UPP en terapia intensiva

Álvarez Ureña, J. G.; Farroñay, J.; Roque Arhuis, L.

Hospital de Clínicas José de San Martín · Servicio de Terapia Intensiva

1 INTRODUCCIÓN

Las úlceras por presión (UPP) comprometen la seguridad del paciente crítico, cuyo riesgo aumenta por inmovilidad y alteraciones de perfusión. Su prevención requiere valoración sistemática y cuidados individualizados (European Pressure Ulcer Advisory Panel et al., 2019). La documentación electrónica puede mejorar los registros de enfermería, aunque la evidencia presenta limitaciones metodológicas (McCarthy et al., 2019). En Terapia Intensiva, falta evaluar si una guía digital accesible mediante **código QR** mejora la estandarización de las valoraciones y el seguimiento de las lesiones. Se propone integrar la Escala de Braden, el esquema TIME y un registro digital para organizar la información, apoyar las decisiones de enfermería y favorecer la continuidad del cuidado entre turnos y la seguridad del paciente.

2 OBJETIVOS

Objetivo General: Implementar una guía digital con registro QR para el abordaje integral de UPP en pacientes críticos.

Objetivos específicos:

- Estandarizar el registro de UPP mediante un formulario digital accesible por QR.
- Sistematizar el seguimiento de la evolución de las lesiones.

La falta de registro continuo de UPP motivó una propuesta digital para documentar cuidados y seguir su evolución.

3 DESCRIPCION DE LA EXPERIENCIA

Diseño: Piloto de innovación asistencial con guía digital y registro de UPP mediante QR

Ámbito y período: UTI del Hospital de Clínicas José de San Martín durante un periodo de 4 semanas del 2026.

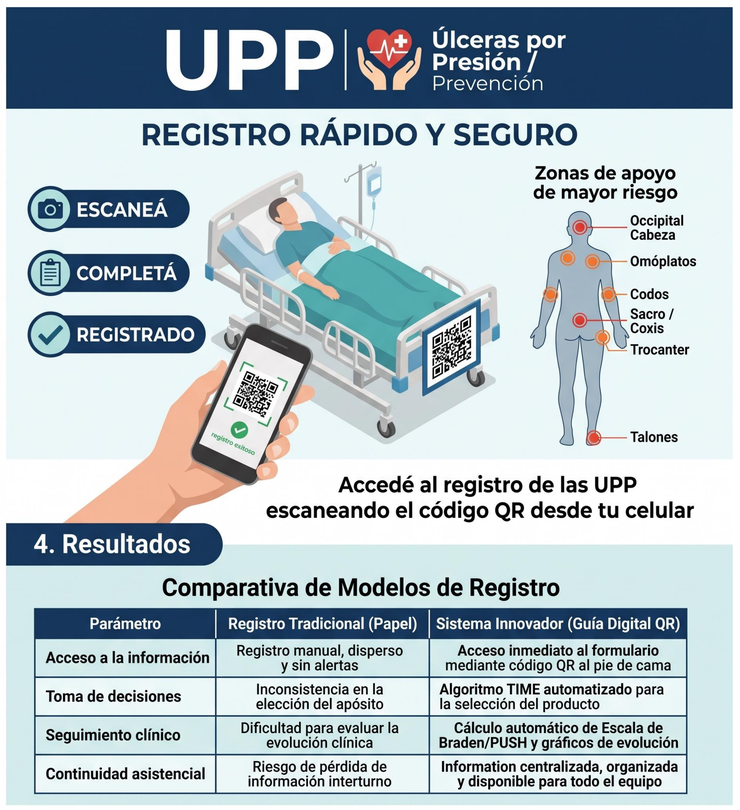
Población o participantes: Se incluirá a 20 pacientes adultos críticos bajo asistencia respiratoria mecánica o con riesgo de desarrollar UPP, mediante muestreo consecutivo.

Intervención o procedimiento: Escanear el QR al pie de cama, inspeccionar la piel y registrar valoración, lesiones y cuidados. Actualizar la información por turno, revisar la evolución y comunicar cambios durante el pase de guardia.

Instrumentos y análisis: Escala de Braden, esquema TIME y formulario digital. Se propone comparar registros sucesivos y describir su completitud mediante frecuencias y porcentajes.

Aspectos éticos: Aval institucional, se prevé acceso restringido y resguardo de la identidad, sin nombres, iniciales, números de historia clínica, fechas exactas ni fotografías con rostros.

4 LOGROS Y APRENDIZAJES



Parámetro	Registro Tradicional (Papel)	Sistema Innovador (Guía Digital QR)
Acceso a la información	Registro manual, disperso y sin alertas	Acceso inmediato al formulario mediante código QR al pie de cama
Toma de decisiones	Inconsistencia en la elección del apósito	Algoritmo TIME automatizado para la selección del producto
Seguimiento clínico	Dificultad para evaluar la evolución clínica	Cálculo automático de Escala de Braden/PUSH y gráficos de evolución
Continuidad asistencial	Riesgo de pérdida de información interturno	Information centralizada, organizada y disponible para todo el equipo

Figura 1. Propuesta de registro digital de UPP mediante código QR y comparación con el registro en papel. *Fuente:* Elaboración propia con asistencia de inteligencia artificial.





Qué se logró:

- Se elaboró una propuesta de formulario digital accesible mediante QR para organizar la valoración de UPP y documentar los cuidados con criterios comunes.
- Se definió un procedimiento de actualización por turno y comparación de registros sucesivos para identificar cambios en la evolución.
- Se incorporó a la propuesta la consulta de la información registrada durante el pase de guardia para apoyar la continuidad del cuidado.

Qué dificultades hubo: Se identificó la ausencia de registros continuos y estandarizados en el servicio.. La implementación del piloto está pendiente, por lo que aún no se dispone de resultados sobre el funcionamiento de la herramienta.

Qué se aprendió: El desarrollo del proyecto permitió reconocer que el QR facilita el acceso al formulario, pero el seguimiento requiere valoraciones sistemáticas y registros completos y actualizados. La participación del equipo de enfermería será fundamental para sostener su utilización. La prueba piloto permitirá identificar dificultades de uso y realizar los ajustes necesarios.

5 CONCLUSIONES

MENSAJE CLAVE

La falta de registros continuos dificulta conocer la evolución de las UPP entre turnos. La propuesta de un registro digital accesible por QR busca facilitar su seguimiento y la continuidad del cuidado.

La propuesta busca estandarizar el registro de UPP mediante QR, facilitar el seguimiento de las lesiones y apoyar la comunicación entre turnos para favorecer la continuidad del cuidado. Su alcance comprende la implementación y evaluación de una prueba piloto en la UTI. Una posible limitación es la carga incompleta o discontinua de datos, que dificultaría comparar valoraciones y disponer de información actualizada. La utilidad de la herramienta deberá evaluarse durante su implementación.

6 APORTE A ENFERMERÍA

- Unificar los criterios de valoración y cuidado de las UPP.
- Facilitar el registro y seguimiento de las lesiones.
- Mejorar la comunicación entre turnos.
- Documentar las intervenciones de enfermería.
- Apoyar las decisiones con información organizada y actualizada.
- Favorecer la continuidad del cuidado.

7 REFERENCIAS

- European Pressure Ulcer Advisory Panel, National Pressure Injury Advisory Panel, & Pan Pacific Pressure Injury Alliance. (2019). *Prevention and treatment of pressure ulcers/injuries: Clinical practice guideline. The international guideline* (E. Haesler, Ed.). Texto completo.
- Govern de les Illes Balears, Conselleria de Salut i Consum. (2007). *Prevención y tratamiento de las úlceras por presión*. ibsalut.es
- Instituto Mexicano del Seguro Social. (2009). *Guía de práctica clínica: Prevención y tratamiento de úlceras por presión en primer nivel de atención*. Texto completo. www.imss.gob.mx
- McCarthy, B., Fitzgerald, S., O'Shea, M., Condon, C., Hartnett-Collins, G., Clancy, M., Sheehy, A., Denieffe, S., Bergin, M., & Savage, E. (2019). Electronic nursing documentation interventions to promote or improve patient safety and quality care: A systematic review. *Journal of Nursing Management, 27*(3), 491–501. https://doi.org/10.1111/jonm.12727.
- World Union of Wound Healing Societies. (2007). *Principios de las mejores prácticas: Exudado en las heridas y utilidad de los apósitos. Documento de consenso*. MEP Ltd
- las heridas y utilidad de los apósitos. MEP Ltd.

Contacto: roque.lizett@gmail.com